

颌面部韧带样纤维瘤的放疗附 8 例报告

张霖 胡海生 王中和

(上海交通大学附属第九人民医院放疗科,上海,200011)

【摘要】 目的 评估三维适形放射治疗在颌面部韧带样纤维瘤治疗中的疗效。方法 对 8 例颌面部韧带样纤维瘤患者进行三维适形放射治疗,3 例单纯放疗,5 例术后放疗,放疗剂量 56–60cGy/28F–30F/6W。结果 对病例全部随访,至少 3 年,最长 10 年,有效率为 87.5%。三年生存率 62.5%,5 年生存率 50%。近、远期均未见不良反应,结论 单纯放射治疗或手术后放射治疗对韧带样纤维瘤均有效,5 年生存率

【关键词】 韧带样纤维瘤;三维适形放射治疗;术后放疗

Reports Of Radiotherapy To Eight Patients With Maxillofacial Desmoid Tumor

【Abstract】 Objective: study of radiotherapy maxillofacial desmoid tumor. Methods: Use of three dimension conformal radiotherapy

目的。因此,长期、系统、个体化给药是高血压治疗的原则[3]。调查显示,钙通道阻滞剂 DDDs 排序居首位,该类药物可迅速而有效地降低舒张压和收缩压,并且能改善冠脉血流,预防脑卒中。因其品种多,降压效果显著,适应证多,不良反应小,得以广泛使用。硝苯地平和非洛地平的控、缓释剂型能产生相对平稳持久的降压效果,也可减少心血管事件[4]。硝苯地平控释片血药浓度时间曲线平缓长久,每服用一次能维持最低有效血药浓度(10ng/ml)以上时间达 12 小时,也就是说作用持久稳定,服药方便,因而受到医患者的普遍认同,这是 DDDs 排序第 1 的主要原因。氨氯地平属于第三代的钙通道阻滞剂,降压作用平稳、持久、缓和,对血脂、血糖及心脏功能无不良影响,口服吸收完全,长期使用不产生耐药性,也不产生血压的明显波动,心脏传导阻滞者禁用。尼群地平对肺气肿并发肺动脉高压有较好效果,不良反应少。

β -受体阻滞剂主要是通过阻断 β_1 受体,使心肌收缩力下降、心排血量减少、心率降低而发挥降压作用,尤其适用于伴有冠心病、心肌梗死后、快速心律失常的轻中度高血压患者。比索洛尔克服了此类药物对脂类及糖类的不良影响,更适用于高血压伴心力衰竭患者,正被认为是长期治疗高血压的安全有效药物[5]。当要停用 β -受体阻滞剂时应注意逐渐停药,否则会引起反射性交感张力增高,形成“反跳”现象。该类药物可抑制或消除人体精子活性,长期使用(特别是青年男性高血压患者)应特别注意。

血管紧张素转换酶抑制剂类抗高血压药物出现咳嗽的不良反应较多,血管紧张素转换酶抑制剂是糖尿病合并高血压的首选治疗药物,临床应用以第一代卡托普利(开搏通)和第二代贝那普利(洛汀新)等较为普遍。贝那普利为前体药物,在肝内水解为贝那普利拉,成为一种竞争性的血管紧张素转换酶抑制剂,使血管紧张素 I 不能转换为血管紧张素 II,结果血管阻力降低,醛固酮分泌减少,血浆肾素活性增高。

血管紧张素 II 受体拮抗剂,它以高亲和力和特异性与血管紧张素 II 受体结合,阻断血管紧张素 II 的压力反应和功能反应,但不影响血管紧张素转换酶,不会导致缓激肽的蓄积,不影响前列腺素合成,故不引起干咳和血管神经性水肿,并能改善血糖、血脂代谢,对靶器官有保护作用。替米沙坦 98% 的原形药经肾排泄,无活性代谢,半衰期为 12~20h,是作用最长的长效血管紧张素 II 受体拮抗剂。血管紧张素 II 受体拮抗剂类对高血压患者的心脏、血管和肾脏有

直接的保护作用,而且这种保护作用不依赖于药物的降血压效应,而且耐受性好,不良反应率低,并且不因剂量的增加而增多[6],是治疗心血管病和肾脏病的一类重要抗高血压药物。

利尿剂能排出体内多余的液体,减少血液的体积,从而达到降压的目的。这类药物可分为强效利尿剂(呋塞米)、中效降压利尿剂(氢氯噻嗪)、弱降压利尿剂(螺内酯)。高血压患者应用利尿剂,应先用中效利尿剂,无效时或有慢性肾衰竭时宜用强利尿剂。使用时,先从小剂量开始,根据病情逐渐加量,尤其是老年人,初始的剂量更要小。痛风患者禁用此类药物。

任何一种降压药都难以使 100% 的患者有效,而加大单药剂量降压效果欠佳,同时会加大不良反应发生的危险性。因此就需要联合应用降压药物。两联用药的方案有:1. 血管紧张素转化酶抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂或钙通道阻滞剂 + 利尿剂,2. 血管紧张素转化酶抑制剂 + 钙通道阻滞剂,3. 血管紧张素转化酶抑制剂 + β -受体阻滞剂,4. β -受体阻滞剂 + α -受体阻滞剂;三联用药的方案有:1. 利尿剂 + β -受体阻滞剂 + 钙通道阻滞剂,2. 利尿剂 + 血管紧张素转化酶抑制剂 + 钙通道阻滞剂,3. 利尿剂 + 血管紧张素 II 受体阻滞剂 + 钙通道阻滞剂。

通过以上分析可知,我院门诊抗高血压药应用基本合理,钙通道阻滞剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂, β -受体阻滞剂和血管紧张素转化酶抑制剂为目前治疗高血压的主要药物。对于确诊高血压的患者,首先应保持健康生活方式,然后在医师的指导下,选择适合自己疾病的药品,并定期监测血压,尽量减少心脑血管疾病的发生率。

参考文献

- [1]曾繁涛,谢杰.抗高血压药物临床用药分析[J].现代医药卫生,2007,23(15):2226.
- [2]罗立平,殷凤,陈悦.抗高血压药物的相互作用[J].现代中西医结合杂志,2009,18(5):537.
- [3]张元宏.高血压病的药物治疗新进展[J].实用医技杂志,2007,14(3):382~385
- [4]黄体钢.原发性高血压个体化治疗的历史和现状[J].现代医药卫生,2003,19(3):2531
- [5]尹桂华.抗高血压药物的分类与合理使用[J].中国热带医学,2007,7(8):1400~1401
- [6]龚培力.抗高血压药物的评价与研究进展[J].医学导报,2007,4(26):334~339

(3D-CRT) to treat 8 cases, 3 cases were treated with radiotherapy, 5 cases were treated with postoperative radiotherapy. Total dose 56–60cGy/28F–30F/6W. Result: Local control rates is 87.5%, 3-year survival rates 62.5%, 5-year survival rates 50%. Conclusion: postoperative radiotherapy and radiotherapy are good method to treating maxillofacial desmoid tumor.

【Keywords】 desmoid tumor 3D-CRT postoperative radiotherapy

韧带样纤维瘤或称侵袭性纤维瘤病是一种具有侵袭性生长,无包膜,手术后局部易复发为特点的疾病,通常发生于腹壁,颌面部少见,治疗上首选手术治疗,放射治疗也有不俗疗效,本文总结我科于1999–2008年收治8例放疗病例。总结如下:

1 材料与方法

1.1 临床资料 1999年4月–2008年6月,在我科行放疗治疗的8例放疗患者,8例中3例为首诊后,即转来行局部放疗治疗的。5例为手术后放疗病例,其中3例为术后复发再手术后转来放疗,5例病例切除后为2例,3例为肉眼肿瘤残余。男性3例,女性5例,发病年龄自21岁至62岁,中位发病年龄为42岁。病变部位:翼腭凹1例,颞下凹2例,口底、颌下区4例,下唇1例。

1.2 治疗方式及疗效评价 单纯放疗3例,手术+放疗5例,放射治疗采用3D-CRT方式治疗,采用U型低温热塑面模固定,再行CT扫描,有原发灶及肉眼残余者,使用增强CT扫描,扫描后,依CT图像确定靶区。GTV:临床肿瘤CTV1:为GTV外放1.0cmCTV2:为CTV1外放1.5cm,或者手术瘤床外放2.0cm。在外放中,波及危急器官,如脊髓、脑干、视N、视交叉等均遵从危急器官优先原则,对靶区进行退缩,采用依可达6MV X线加速器治疗,剂量达56–60cGy/28F–30F/6W方案治疗。

1.3 治疗评价 分为完全缓解(CR),部分缓解(PR),稳定(SD),进展(PD),以CT或MRI为评判方式。

1.4 随访与统计方法 放疗后一月开始复片检查,随访至2011.1月,随访率100%,统计方法采用Kaplan-Meier方法。

2 结果

2.1 患者局部控制率 所有患者均按照设定的放疗方案完成治疗,没有拖延治疗。

单纯放疗:一般不立即消退,一例8个月后消退,未有复发,一例12个月后消退,18个月后复发,7个月后死亡。一例未控,10月后死亡。手术+放疗的患者:3例切缘阳性者,未见有复发,2例肉眼残余肿瘤者,一例2年后复发,再次手术,再复发,复发者4个月后死亡,一例3年后复发,未治疗,6月后死亡。

2.2 预后 面部控制率,单纯放疗组66.7%(2/3),手术+放疗组80%(4/5)。总控制率75%(6/8)。三年生存率62.5%(5/8),五年生存率50%(4/8)

3 讨论

韧带样纤维瘤或侵袭性纤维瘤病,是Muller于1838年首次提出,一直被认为是面部侵袭,无包膜,易复发的特点。但是一直认为是良性病变,但又有别于其它良性肿瘤[1]。它主要发生于肌肉、腱膜和深筋膜等处的良性肌腱膜过度增生,成年人好发于躯干,儿童好发于四肢,腹壁的侵袭性纤维瘤最常见,颌面部少见。本组报道也有同样的情况。增强的CT和MRI检查,对确定肿瘤的大小范围及边界有

明显的帮助,但不能帮助定性,将CT及MRI图像融合,有助于手术及放疗范围的确定。

外科手术无疑是本病治疗的首选方案,但是肿瘤无包膜,且侵袭性生长,术前无法很快确定范围,且因范围大,很容易造成器官或肢体功能障碍,且切除不完全,造成肿瘤切缘阳性或肉眼残余,最终肿瘤复发。Micke[2]统计,手术切除阴性(R0)局部复发率12–27%,切除阳性(R1)复发率42–68%,切除肉眼阳性(R2)局部复发率为100%。Micke Meta分析了698例患者,放疗对此病有效,可以提高手术的疗效,R0提高17%,R1提高40%,R2提高78%。Muytens[3]的文章指出,手术+术后放疗的面控率在80%。本组病例中也证明放疗是治疗本病的有效手段。尤其是肉眼阳性的患者,放射治疗极大地降低了局部复发率。本组报道中的数据也显示,术后切缘阳性患者的局控率明显优于肉眼阳性者。

Nuytens [3] 统计了102例单纯放疗病员的面控率为78%。Spear [4] 治疗了15例单纯放疗病员,5年面控率为93%。Baumert[5]报道放疗剂量低于50Gy和大于60Gy的面控率为38%和88%,提示放疗剂量要>60Gy,放疗是有效的。我们认为临床治疗中很难证明手术+术后放疗明显优势于单纯放疗,但是无论单纯放疗,还是手术+术后放疗,均证明放疗有效。我们也同意将放疗剂量调至56–60Gy,放射治疗前的靶区勾画和计划制定时,应尽可能减少周围重要器官及软组织的受量,采用3D-CRT方式治疗,本组随访中未见有明显不良反应及后遗症。

至于采用化疗或激素治疗目前尚存争议,但放疗或手术+术后放疗的模式已被肯定,放疗尤其是对无法手术或手术会造成功能和外形损害明显的病员,采用放疗是个好方法,是一种成熟的治疗手段。

参考文献

- [1]Wang CP, et al. Desmoid tumor of the head and neck [J]. Head Neck, 2006,28(11):1008–1013
- [2]Micke O, Seegenschmiedt MH. Radiation therapy for aggressive fibromatosis (desmoid tumors) results of a national patterns of care study[J]. Int.J Radiat Oncol.Biolphys, 1998,42(5):1007–1101
- [3]Nuytens JJ, Rust PF, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors?: a comparative review of desmoid 22 articles[J]. Cancer, 2000,88(7):1517–1523
- [4]Baumert BG, et al. The impact of radiotherapy in the treatment of desmoid tumors. An international survey of 110 patients. A study of the Rare Cancer Network[J]. Radiat Oncol, 2007,5(7):12

作者简介:张霖,男,(1966.8–),上海,本科学士,主治医师,研究方向:头颈肿瘤

基金项目:上海市重点学科(优势学科)建设项目资助(YO203)